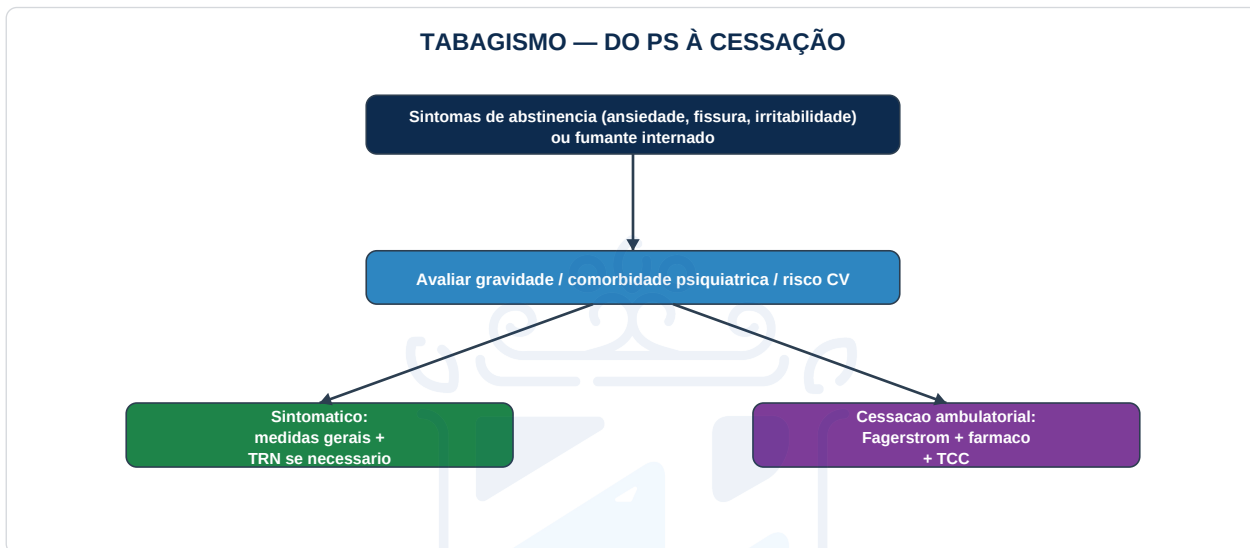


ABSTINÊNCIA À NICOTINA E TABAGISMO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

ABSTINÊNCIA À NICOTINA

- Conjunto de manifestações neuropsiquiátricas e autonômicas pela interrupção/redução abrupta do tabaco em dependentes
- Sintomas intensos impactam a adesão e levam à recaída — é condição clínica reconhecida
- Gatilhos: suspensão abrupta, internação sem reposição, redução involuntária, estresse físico/emocional
- No PS o tratamento é PREFERENCIALMENTE SINTOMÁTICO — não é emergência isolada (salvo associações)

QUANDO SUSPEITAR — SINTOMAS

QUADRO DE ABSTINÊNCIA

- Ansiedade, irritabilidade, inquietação psicomotora
- Cefaleia, insônia, dificuldade de concentração
- Fissura intensa (craving)
- Bradicardia leve e aumento do apetite
- Tipicamente após suspensão abrupta (incl. internação hospitalar)

CHECKLIST DE GRAVIDADE (PS)

AVALIAR SEMPRE

- ☐ Comorbidades psiquiátricas
- ☐ Risco cardiovascular recente (IAM / AVC)
- ☐ Uso concomitante de álcool / outras drogas
- ☐ Risco de autoagressão / autoextermínio

TRATAMENTO NO PS

Rx MANEJO SINTOMÁTICO

Medidas gerais: ambiente calmo, acolhimento, psicoeducação
Evitar contenção farmacológica desnecessária
Terapia de reposição de nicotina (TRN) se necessário:
Goma de nicotina 2mg VO sob demanda a cada 1-2h, OU
Adesivo transdérmico 7-14 mg/dia (se internação)
Preferir doses MENORES em IAM/AVC recente (evitar picos -> preferir adesivo)

TESTE DE FAGERSTRÖM — GRAU DE DEPENDÊNCIA

Pontuação	Dependência	Implicação
0 - 2	Muito baixa	Aconselhamento; TRN se sintomas
3 - 4	Baixa	Aconselhamento + considerar TRN
5	Moderada	Farmacoterapia + TCC
6 - 7	Alta	Farmacoterapia + TCC
8 - 10	Muito alta	Farmacoterapia + TCC (doses plenas)

FARMACOTERAPIA — TRN (ADESIVO POR CARGA TABÁGICA)

Cigarros/dia	Adesivo	Observação
> 20	21 mg/dia	Reduzir progressivamente em 6-12 semanas
10 - 20	14 mg/dia	Pode associar goma/pastilha sob demanda
< 10	7 mg/dia	Goma/pastilha 2-4mg (máx 15-20/dia)

FARMACOTERAPIA — BUPROPIONA E VARENICLINA

Rx BUPROPIONA SR

Dia 1-3: 150mg VO 1x/dia
A partir do dia 4: 150mg VO 12/12h (7-12 semanas)
REDUZ O LIMiar CONVULSIVO
Contraindicada: epilepsia/convulsão, distúrbio alimentar,
abstinência de álcool/BZD, IMAO, TCE recente
Adversos: insônia, boca seca, ansiedade

Rx VARENICLINA

Dia 1-3: 0,5mg VO 1x/dia
Dia 4-7: 0,5mg VO 12/12h
A partir do dia 8: 1mg VO 12/12h (12 semanas)
Adversos: náuseas, sonhos vívidos
Monitorar sintomas psiquiátricos

RECOMENDAÇÃO MS / INCA

PRINCÍPIO DO TRATAMENTO

- Todo paciente com dependência MODERADA a ALTA deve receber farmacoterapia ASSOCIADA à TCC
- TCC: enfrentamento do craving, identificação de gatilhos, acompanhamento semanal inicial
- Abordagem multiprofissional (Programa Nacional de Controle do Tabagismo)
- Seguimento: retorno em 7-14 dias, ajuste de doses e reforço motivacional contínuo

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO E ALTA

DECISÃO

- INTERNAR: abstinência com surto psiquiátrico, risco de autoextermínio, uso de múltiplas substâncias, comorbidade clínica descompensada
- ALTA: sintomas controlados + orientações fornecidas + encaminhamento ambulatorial estruturado
- Encaminhar todo fumante motivado ao programa de cessação (ambulatório/UBS)

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente internado, fumante de 25 cigarros/dia, desenvolve ansiedade, irritabilidade e fissura intensa. Qual a melhor conduta?

- A) Contenção física e sedação profunda
- B) Medidas gerais + terapia de reposição de nicotina (ex.: adesivo)
- C) Bupropiona em dose plena imediata, independentemente de contraindicações
- D) Apenas observação, pois não há tratamento para abstinência
- E) Benzodiazepínico de longo prazo como primeira linha

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual condição é contraindicação ABSOLUTA ao uso de bupropiona?

- A) Hipertensão controlada
- B) Diabetes tipo 2
- C) História de epilepsia / convulsão
- D) Dislipidemia
- E) Doença do refluxo

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Segundo o MS/INCA, qual a recomendação para o paciente com dependência moderada a alta (Fagerström)?

- A) Apenas aconselhamento breve
- B) Apenas terapia cognitivo-comportamental
- C) Farmacoterapia associada à terapia cognitivo-comportamental (TCC)
- D) Internação compulsória
- E) Acompanhamento anual sem medicação

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Paciente com IAM há 1 semana solicita ajuda para abstinência de nicotina. Sobre a TRN, qual o cuidado adequado?

- A) Está absolutamente contraindicada em qualquer dose
- B) Usar as maiores doses possíveis para controle rápido
- C) Preferir doses menores (7-14 mg) e evitar picos, dando preferência ao adesivo
- D) Substituir obrigatoriamente por vareniclina em dose dobrada
- E) Suspender qualquer abordagem até 6 meses do evento

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o manejo da abstinência à nicotina no PS, assinale a correta:

- A) É uma emergência médica isolada que exige UTI
- B) O tratamento é preferencialmente sintomático, salvo associação com outros quadros graves
- C) Sempre exige internação psiquiátrica
- D) A reposição de nicotina é proibida no ambiente hospitalar
- E) Não há relação entre abstinência e recaída

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Abstinência à nicotina em internado: tratar de forma sintomática com medidas gerais e TRN (adesivo conforme carga tabágica). Evita-se contenção/sedação desnecessária; benzodiazepínico de longo prazo não é primeira linha.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Bupropiona reduz o limiar convulsivo — epilepsia/história de convulsão é contraindicação absoluta, assim como distúrbios alimentares, abstinência de álcool/BZD, uso de IMAO e TCE recente.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

MS/INCA: dependência moderada a alta deve receber farmacoterapia ASSOCIADA à TCC. Nenhuma das duas isoladamente é a recomendação preferencial nesse grau de dependência.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Em IAM/AVC recente, a TRN não é proibida, mas deve usar doses menores (7-14 mg) e evitar picos de nicotina — preferindo o adesivo isolado pela liberação mais estável.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No PS o tratamento da abstinência é preferencialmente sintomático e não configura emergência isolada, exceto quando associada a surto psiquiátrico, risco de autoextermínio ou descompensação clínica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico